

🎯 治疗决策树 & 放疗处方剂量速查

住培结业考试专用 · 12癌种对比记忆版 重点：决策树 → 放疗分类 → 靶区定义 → 处方剂量 📌 = 高频考点/易混点 · △ = 条件判断

✦ 处方剂量速查总表

📌 先背这张表，再看各论。把数字和癌种绑定记忆。

根治性放疗剂量总览

癌种	GTV-P	GTV-N (阳性LN)	CTV高危	CTV低危	分次
鼻咽癌 NPC	69.96 Gy	66-69.96 Gy	60 Gy	54 Gy	33f, SIB
扁桃体癌	69.96-70 Gy	69.96-70 Gy	59.4 Gy	54 Gy	33f, SIB
下咽癌	69.96-70 Gy	69.96-70 Gy	59.4 Gy	54 Gy	33f, SIB
NK/T淋巴瘤	50-56 Gy	—	50 Gy	—	25-28f
脑胶质瘤 (HGG)	60 Gy	—	含在CTV中	—	30f
食管癌	60(-66) Gy	60(-66) Gy	50 Gy	—	30f
肺癌 (NSCLC)	60-66 Gy	60-66 Gy	(50 Gy)	—	30-33f
宫颈癌	EBRT 45-50.4 + 腔内加量	60-65 Gy(SIB)	45-50.4 Gy	—	25-28f

术后放疗剂量总览

癌种	瘤床/高危区	亚临床区	分次	备注
脑胶质瘤(HGG)	60 Gy	—	30f	同步TMZ
乳腺癌(保乳)	全乳50 Gy + 瘤床加量10-16 Gy	—	25f+5-8f	或大分割 42.56/16f
乳腺癌(根治术后)	胸壁50 Gy	区域LN 50 Gy	25f	
子宫内膜癌	45-50.4 Gy	±阴道残端加量	25-28f	VBt: 6Gy×3f
直肠癌(术后)	45-50.4 Gy + 加量5.4 Gy	45 Gy	25-28f	
胰腺癌	45-50.4 Gy	—	25-28f	

新辅助放疗剂量总览

癌种	方案	剂量	分次
食管癌(CROSS)	新辅助放化疗	41.4 Gy	23f
直肠癌(长程)	新辅助放化疗	50-50.4 Gy	25-28f
直肠癌(短程)	新辅助放疗	25 Gy	5f
胰腺癌(SBRT)	新辅助/转化	33-40 Gy	5f

📌 剂量记忆锚点

- **70 Gy档**：鼻咽、扁桃体、下咽（头颈鳞癌三兄弟，都是约70/33f）
- **60 Gy档**：脑胶质瘤60/30f、食管癌60/30f、肺癌60-66/30f
- **50 Gy档**：NK/T淋巴瘤50-56 Gy、乳腺癌50/25f、术后盆腔45-50.4 Gy
- **特殊记忆**：CROSS 41.4/23f（唯一的41.4）、短程直肠25/5f

1. 鼻咽癌 Nasopharyngeal Carcinoma (NPC)

治疗决策树

鼻咽癌（病理确诊）
├ T1N0（早期）→ 单纯根治性放疗（IMRT）
└ T1N1-3 / T2-3任何N → 同步放化疗（DDP）± 诱导化疗

└ T4任何N / 任何TN2-3 (局晚) → 诱导化疗 (GP/TPF) → 同步放化疗
└ M1 (远处转移) → 姑息化疗 ± 局部放疗

△ 诱导化疗适应证：局部晚期 (III-IVA期)，尤其N2-3或T4 ➡ 鼻咽癌以放疗为核心，不做手术 (解剖位置深、放疗敏感)

放疗分类：根治性放疗

靶区	定义	处方剂量
GTV-P	原发肿瘤 (鼻咽+受侵结构)	69.96 Gy/33f (2.12 Gy/f)
GTV-N	转移淋巴结	66-69.96 Gy/33f
CTV1 (高危)	GTV-P外扩5-10mm + 高危受侵区 (颅底、鼻腔、口咽、咽旁间隙) + 咽后LN + 同侧颈II-III区	60 Gy/33f (1.82 Gy/f)
CTV2 (低危)	双侧颈部IV-V区 + 锁骨上区 (N0可不包含V区下段)	54 Gy/33f (1.64 Gy/f)
PTV	各CTV外扩3-5mm	同对应CTV

➡ 鼻咽癌是SIB (同步加量) 的经典模型 ➡ 咽后淋巴结是鼻咽癌首站转移，必须包含在CTV1

2. 扁桃体癌 Tonsillar Carcinoma

治疗决策树

扁桃体癌 (口咽鳞癌)
└ 早期 (T1-2N0-1)
└ └ 方案1：根治性放疗 (±同步化疗) ➡ 优选
└ └ 方案2：经口手术 (TORS) → 根据病理决定是否术后放疗
└ 局部晚期 (T3-4 或 N2-3)
└ └ 方案1：同步放化疗 (DDP)
└ └ 方案2：手术 → 术后放疗/放化疗
└ M1 → 姑息化疗 ± 免疫

△ HPV(+)预后好，但目前标准治疗方案不因HPV状态改变 ➡ 扁桃体癌是口咽癌最常见亚型，对侧颈部转移率高→双侧颈部照射

放疗：根治性

靶区	定义	处方剂量
GTV-P	原发肿瘤	69.96-70 Gy/33f
GTV-N	转移淋巴结	69.96-70 Gy/33f
CTV1 (高危)	GTV外扩5-10mm + 同侧口咽 + 咽后LN + 高危颈部LN区 (II-III区)	59.4 Gy/33f
CTV2 (低危)	双侧颈部II-V区 + 对侧咽后LN	54 Gy/33f

放疗：术后

条件	剂量
高危 (切缘+和/或ECE+)	60-66 Gy/30-33f (瘤床)，同步DDP
中危 (pT3-4/N2+/LVI+/PNI+)	54-60 Gy/30f
低危区域	50-54 Gy

➡ 术后放疗启动同步化疗的指征 = 切缘阳性(positive margin) 或 淋巴结包膜外侵犯(ECE)

3. 下咽癌 Hypopharyngeal Carcinoma

治疗决策树

下咽癌
└ 早期 (T1-2N0)
└ └ 方案1：根治性放疗 (保喉) ➡ 优先保喉

- └ 方案2：手术（部分喉咽切除）
- └ 局部晚期（T3-4a 或 N+）
 - └ 喉功能保留意愿 → 诱导化疗（TPF）
 - └ CR/PR → 同步放化疗（根治）
 - └ SD/PD → 手术（全喉+全下咽切除）→ 术后放疗
 - └ 无保喉意愿/T4b → 手术 → 术后放化疗
- └ M1 → 姑息化疗 ± 免疫

△ 下咽癌恶性度高，就诊多为晚期，预后较差 ➡ 保喉策略：诱导化疗筛选 → 有效者放化疗，无效者手术

放疗：根治性（保喉）

靶区	定义	处方剂量
GTV-P	原发肿瘤（梨状窝/环后区/咽后壁）	69.96-70 Gy/33-35f
GTV-N	转移淋巴结	69.96-70 Gy/33-35f
CTV1（高危）	GTV外扩5-10mm + 同侧喉 + 下咽黏膜 + 颈部II-IV区	59.4 Gy/33f
CTV2（低危）	双侧颈部II-V区 + 气管食管沟LN	54 Gy/33f

放疗：术后

条件	剂量
高危（切缘+/ECE+）	60-66 Gy/30-33f ，同步DDP
标准	54-60 Gy/30f

➡ 下咽癌的淋巴引流：梨状窝癌→同侧II-IV区；环后区癌→双侧II-VI区+咽后LN ➡ 与鼻咽癌/扁桃体癌剂量一致（头颈鳞癌**70 Gy**统一记忆）

4. NK/T细胞淋巴瘤（鼻型） Extranodal NK/T-cell Lymphoma, Nasal Type

治疗决策树

- NK/T细胞淋巴瘤（鼻型）
 - └ 早期（I-II期，局限于上气道）
 - └ ➡ 放疗为核心 + 含左旋门冬酰胺酶（L-Asp）方案化疗
 - └ 方案1：夹心疗法（化疗-放疗-化疗）
 - └ 方案2：序贯（化疗→放疗 或 放疗→化疗）
 - └ 方案3：同步放化疗
 - └ 晚期（III-IV期）
 - └ 系统化疗为主（SMILE/P-Gemox/DDGP）± 巩固放疗
 - └ 复发/难治 → 免疫治疗（PD-1）/异基因移植

△ NK/T淋巴瘤对传统CHOP方案不敏感（P-gp介导多药耐药） ➡ 化疗核心药物 = 左旋门冬酰胺酶（L-Asp） ➡ 放疗对NK/T淋巴瘤极为敏感，早期以放疗为核心

放疗：根治性（早期）

靶区	定义	处方剂量
GTV	化疗前原发灶范围（参考治疗前MRI/PET）	50-56 Gy/25-28f
CTV	GTV + 受侵区域邻近结构（鼻腔→对侧鼻腔、筛窦、上颌窦内壁、硬腭、鼻咽）	50 Gy/25f
PTV	CTV外扩3-5mm	同CTV

△ 累及野(involved-field)照射，不常规预防颈部 ➡ 与头颈鳞癌的区别：剂量低得多（50-56 vs 70 Gy），照射范围也更局限 ➡ 化疗前范围勾画GTV（不是化疗后缩小的范围）

5. 脑胶质瘤 Glioma

治疗决策树

脑胶质瘤

- 低级别胶质瘤 (WHO II级/IDH突变型)
 - 肿瘤<全切 或 年龄≥40 或 有高危因素
 - 术后放疗 + 化疗 (TMZ或PCV)
 - 全切 + 无高危因素 → 密切随访
- 高级别胶质瘤 (WHO III级)
 - 术后 → 同步放化疗 (TMZ) → 辅助TMZ
- 胶质母细胞瘤 GBM (WHO IV级)
 - ≤70岁 KPS≥60 → Stupp方案: 术后同步放化疗 (60Gy+TMZ) → 辅助TMZ×6周期
 - 老年/体弱 → 短程放疗 (40Gy/15f) ± TMZ
 - KPS极差 → 最佳支持治疗
- △ 检测MGMT启动子甲基化状态 (影响TMZ疗效)

☛ Stupp方案 = GBM的金标准: 同步放化疗+辅助TMZ

放疗: 术后 (GBM / 高级别胶质瘤)

靶区	定义	处方剂量
GTV 术腔 + MRI T1增强残留病灶	—	—
CTV GTV + FLAIR/T2异常信号区 + 外扩2 cm	—	—
PTV CTV外扩3-5 mm		60 Gy/30f (2 Gy/f)

△ CTV外扩需沿白质纤维束方向修剪, 受脑室、颅骨、大脑镰等解剖屏障限制 ☛ GBM的CTV外扩 = 2 cm (最大的CTV外扩距离之一, 因为沿白质浸润)

放疗: 低级别胶质瘤 (WHO II级)

处方 剂量
标准 50.4 Gy/28f 或 54 Gy/30f

☛ 低级别 = 50.4-54 Gy; 高级别/GBM = 60 Gy (差10 Gy, 好记)

6. 食管癌 Esophageal Carcinoma

治疗决策树

食管癌

- 可切除 (cT1b-T3 或 cN+, 可手术)
 - ☛ 新辅助放化疗 → 手术 (CROSS方案) — 鳞癌+腺癌均适用
 - 或 新辅助化疗 → 手术
 - 术后病理高危 → 可考虑术后放疗
- 颈段食管癌
 - ☛ 根治性同步放化疗 (不手术, 保喉)
- 不可切除/拒绝手术
 - 根治性同步放化疗 (DDP+5-FU / 紫杉醇+DDP)
- T1a → 内镜下切除 (EMR/ESD)
- M1 → 姑息化疗/免疫 ± 姑息放疗

☛ CROSS方案 = 新辅助放化疗的里程碑试验: 41.4 Gy/23f + 紫杉醇/卡铂

放疗: 根治性

靶区	定义	处方剂量
GTV-T	食管原发肿瘤 (CT/EUS/PET确定, 参考钡餐+胃镜夹标记)	60 Gy/30f (2 Gy/f)
GTV-N	转移淋巴结	60 Gy/30f
CTV	GTV-T上下扩3-5 cm + 径向扩0.5-1 cm + 区域淋巴引流区	50 Gy/30f
PTV	CTV外扩5-10mm	同CTV

△ 上下扩展距离大 (3-5cm), 因食管黏膜下层淋巴浸润广泛

放疗: 新辅助 (CROSS方案)

靶区 处方剂量
GTV + 上下3cm + 径向1cm 41.4 Gy/23f (1.8 Gy/f)

放疗：术后

适应证 剂量
R1/R2切缘 或 纵隔淋巴结阳性 **50-54 Gy/25-28f**

☛ 数字记忆：根治60，CROSS 41.4，术后50 ☛ 食管癌CTV纵向外扩最大（3-5cm），远超其他癌种

7. 肺癌 Lung Cancer

治疗决策树

非小细胞肺癌 NSCLC
├ 早期可手术（I-II期）→ 手术（肺叶切除+纵隔淋巴结清扫）
│ └ 术后高危（N2/切缘+）→ 辅助化疗 ± 术后放疗（PORT争议大）
├ 早期不可手术（I期）→ ☛ SBRT
├ 局部晚期（III期）
│ └ 可切除（IIIA选择性）→ 新辅助治疗 → 手术
│ └ 不可切除（IIIB/C）→ ☛ 同步放化疗 → 免疫巩固（Durvalumab）
└ 晚期（IV期）→ 系统治疗（靶向/免疫/化疗）± 姑息放疗

小细胞肺癌 SCLC
├ 局限期（LS）→ 同步放化疗 → ☛ PCI（全脑预防照射）
└ 广泛期（ES）→ 化疗+免疫 ± 胸部巩固放疗 ± PCI

☛ PACIFIC方案 = III期NSCLC同步放化疗后Durvalumab巩固

放疗：NSCLC根治性（III期同步放化疗）

靶区	定义	处方剂量
GTV-P	原发肺内病灶	60-66 Gy/30-33f
GTV-N	阳性纵隔/肺门淋巴结	60-66 Gy/30-33f
CTV	GTV-P外扩 6-8mm + GTV-N外扩 5mm	含在同一剂量水平或略低
PTV	CTV外扩 5mm （IGRT下可缩小）	同CTV

△ 不常规预防性淋巴结照射（ENI已被累及野IFI替代）

SBRT（早期不可手术）

	类型	处方
周围型		48-54 Gy/3f 或 50 Gy/5f (BED ₁₀ ≥100 Gy)
中央型		50 Gy/5f 或 60 Gy/8f （避免过高单次剂量损伤中央结构）

☛ SBRT关键指标：**BED₁₀ ≥ 100 Gy** 才能保证局控

SCLC 局限期放疗

方案	剂量
标准（早期同步）	45 Gy/30f, BID （每天2次，1.5Gy/f）
替代（QD）	60-70 Gy/30-35f
PCI	25 Gy/10f

☛ SCLC放疗应尽早启动（化疗第1-2周期同步开始） ☛ 45/30 BID = SCLC特有的超分割方案

8. 乳腺癌 Breast Cancer

治疗决策树

乳腺癌
├ 早期（I-II期）
│ └ 保乳手术（BCS）→ ☛ 全乳放疗 ± 瘤床加量

- └ 改良根治术 (MRM)
 - └ 高危 (T3-4/N2-3/切缘近) → 术后胸壁+区域LN放疗
 - └ 中危 (N1) → 术后胸壁+区域LN放疗 (推荐)
- └ 局部晚期 (III期)
 - └ 新辅助化疗 → 手术 → 术后放疗
- └ 炎性乳腺癌 → 新辅助化疗 → MRM → 术后放疗 (必须放疗)
- └ IV期 → 系统治疗 ± 姑息放疗

△ 保乳术后放疗是**标准配套**，不可省略 ➡ 改良根治术后放疗指征：T3-4、N+ (≥1个阳性淋巴结，尤其≥4个)、切缘阳性/近切缘

放疗：保乳术后

靶区	定义	处方剂量
全乳	保乳术后同侧乳房	50 Gy/25f
瘤床加量	术腔 (手术夹标记) + 外扩1-2cm	+10-16 Gy/5-8f
大分割替代 全乳		42.56 Gy/16f 或 40 Gy/15f

➡ 大分割已成主流 (≥50岁、pN0、无化疗指征的患者优选)

放疗：改良根治术后

靶区	定义	处方剂量
胸壁	同侧胸壁 (含手术瘢痕)	50 Gy/25f
锁骨上区	同侧锁骨上+下淋巴结区	50 Gy/25f
腋窝 (选择性)	腋窝未充分清扫时	50 Gy/25f
内乳区 (选择性)	内侧/中央象限 且 腋窝淋巴结阳性	50 Gy/25f

➡ 乳腺癌放疗剂量相对“低温和” (50 Gy为基础)，因为是术后辅助 ➡ 保乳 vs 根治术后的区别：全乳照射 vs 胸壁照射；保乳需瘤床加量

9. 胰腺癌 Pancreatic Cancer

治疗决策树

- 胰腺癌
- └ 可切除 → 手术 (Whipple/体尾切除) → 辅助化疗 (mFOLFIRINOX/GemCap)
 - └ 术后高危 (R1/N+) → 可加术后放疗
 - └ 交界可切除 (BRPC) → ➡ 新辅助治疗 (化疗±放疗) → 再评估手术
 - └ 局部进展不可切除 (LAPC)
 - └ 化疗 (FOLFIRINOX/GnP) → 评估
 - └ 转化成功 → 手术
 - └ 稳定/进展 → 同步放化疗 或 SBRT
 - └ 转移性 → 姑息化疗 ± 免疫

△ 胰腺癌手术率低 (仅15-20%可切除)，化疗是基础 ➡ 胰腺癌放疗地位有争议，常作为化疗后的巩固/转化手段

放疗：术后辅助

靶区	定义	处方剂量
CTV	术前肿瘤范围(瘤床) + 手术吻合口 + 区域淋巴引流区	45-50.4 Gy/25-28f
PTV	CTV外扩5-10mm (呼吸运动大)	同CTV

放疗：SBRT

靶区	处方
GTV (可见残留/原发灶)	33-40 Gy/5f 或 25 Gy/1f

△ SBRT需注意十二指肠/胃壁剂量限制 (消化道耐受差) ➡ 胰腺癌放疗剂量偏保守 (常规分割45-50.4 Gy)，受限周围OAR

10. 宫颈癌 Cervical Cancer

治疗决策树

宫颈癌

- 早期
 - IA1 (无LVSI) → 锥切/单纯子宫切除
 - IA1 (LVSI+) - IA2 → 改良根治性子宫切除 + 盆腔淋巴结清扫
 - IB1 - IIA1 (≤4cm) → 根治性子宫切除 或 根治性放疗
 - 术后高危 → 术后放化疗
 - IB2 - IIA2 (>4cm) → 同步放化疗 (EBRT+近距离) 为主
- 局部晚期 (IIB - IVA)
 - 根治性同步放化疗 (DDP周疗) + 近距离放疗 (BT)
- IVB (远处转移) → 姑息化疗/免疫 ± 局部放疗
- △ 术后Sedlis标准/Peters标准判断辅助治疗

● Sedlis标准 (中危) : LVSI/肿瘤大小/浸润深度组合 → 术后放疗 ● Peters标准 (高危) : 切缘+/淋巴结+/宫旁浸润+ → 术后同步放化疗

放疗 : 根治性 (EBRT + 近距离)

靶区	定义	处方剂量
GTV-T	宫颈原发灶 (MRI T2 + PET)	EBRT部分含在大野中
GTV-N	阳性淋巴结	60-65 Gy/SIB
CTV	宫颈 + 子宫体(部分) + 宫旁组织 + 阴道上段(至少3cm) + 盆腔LN区 (髂总、髂外、髂内、骶前、闭孔)	45-50.4 Gy/25-28f
PTV	CTV外扩7-10mm	同CTV
近距离放疗(BT)	宫颈原发灶加量	HDR: A点 6-7 Gy × 4-5次 ● 原发灶总EQD2目标 : 80-90 Gy

△ 近距离放疗OAR用 **D2cc (EQD2)** 评估 (GEC-ESTRO标准) ● EBRT + BT合计原发灶 **EQD2 ≥ 85 Gy** 是疗效保障的关键

放疗 : 术后

指征	靶区	剂量
中危(Sedlis)	盆腔 (阴道残端+宫旁+盆腔LN区)	45-50.4 Gy/25-28f
高危(Peters)	同上 ± 阴道残端加量	45-50.4 Gy + 同步DDP
腹主动脉旁LN+	延伸野至肾血管水平	45 Gy

11. 子宫内膜癌术后 Endometrial Carcinoma (Post-op)

治疗决策树

子宫内膜癌 (术后分期为主)

- 低危 (IA G1-2, LVSI-) → 观察随访
- 中低危 (IA G3 或 IB G1-2, LVSI-) → 单纯阴道残端近距离放疗 (VBT)
- 中高危 (IB G3 或 LVSI+ 或 ≥60岁合并≥2个中危因素)
 - VBT 或 盆腔EBRT (个体化选择)
- 高危 (II期/III期 或 非子宫内膜样/浆液性/透明细胞)
 - 盆腔EBRT ± VBT ± 化疗
- IVB → 化疗为主 ± 姑息放疗

△ 子宫内膜癌分子分型 (POLE突变/MSI-H/p53突变/NSMP) 正在影响治疗决策 ● 中危的核心选择题 : **VBT vs EBRT** (PORTEC-2: VBT不劣于EBRT对于中高危)

放疗 : 术后EBRT

靶区	定义	处方剂量
CTV	阴道残端 + 宫旁区域 + 盆腔LN区 (髂总、髂外、髂内、骶前、闭孔)	45-50.4 Gy/25-28f
PTV	CTV外扩7mm	同CTV

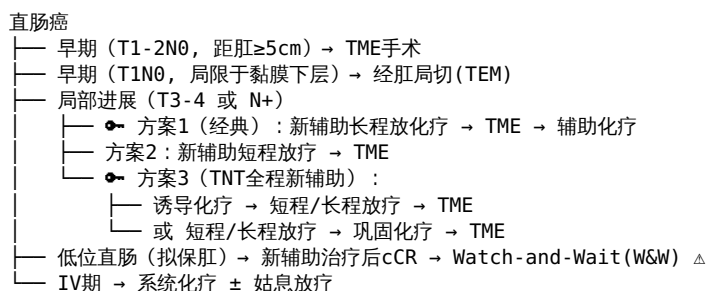
放疗：阴道残端近距离放疗(VBT)

方案	剂量
单纯VBT	HDR: 阴道黏膜面下5mm处 6 Gy × 3次 或 7 Gy × 3次
EBRT后VBT加量	HDR: 4-6 Gy × 2-3次

🔑 子宫内膜癌 vs 宫颈癌放疗区别：- 子宫内膜癌 = 术后放疗为主，腔内放疗用于**阴道残端** - 宫颈癌 = **根治性放疗**为主，腔内放疗用于**宫颈原发灶**加量

12. 直肠癌 Rectal Cancer

治疗决策树



🔑 TNT (全程新辅助治疗) 是当前趋势，提高pCR率 🔑 Watch-and-Wait适用于新辅助治疗后**临床完全缓解(cCR)**的患者

放疗：新辅助长程放化疗

靶区	定义	处方剂量
GTV-T	直肠原发肿瘤	含在CTV内统一剂量
GTV-N	阳性系膜/盆腔淋巴结	含在CTV内
CTV	直肠系膜 (肿瘤上下各2-5cm) + 骶前区 + 髂内LN区 + 闭孔LN区 ± 髂外LN(T4侵犯前方)	50-50.4 Gy/25-28f
PTV	CTV外扩5-7mm	同CTV
GTV加量 (选择性)	cT4/切缘受威胁的原发灶	+4-5.4 Gy

放疗：新辅助短程

方案	剂量
短程放疗	25 Gy/5f (5 Gy/f) → 1周内完成

△ 短程放疗后可等待6-8周再手术 (延长间隔可提高降期率)

放疗：术后 (未行新辅助放疗时)

条件	剂量
标准	45-50.4 Gy/25-28f
瘤床加量 (R1/CRM+)	+5.4 Gy/3f

🔑 直肠癌放疗的特点：新辅助为主，术后放疗仅限于术前未放疗的高危患者 🔑 长程50 Gy vs 短程25 Gy是最常考的对比

✳ 易混点对比速记

头颈部三兄弟 (鼻咽 vs 扁桃体 vs 下咽)

对比项	鼻咽癌	扁桃体癌	下咽癌
治疗核心	放疗 (不手术)	放疗或手术均可	优先保喉放化疗

GTV剂量 69.96 Gy/33f 69.96-70 Gy/33f 69.96-70 Gy/33f
特殊点 咽后LN必包 HPV相关，双侧颈照 诱导化疗筛选保喉
分期系统 第8版NPC专用 AJCC口咽(HPV分开) AJCC下咽

盆腔三姐妹 (宫颈 vs 内膜 vs 直肠)

对比项	宫颈癌	子宫内膜癌	直肠癌
放疗时机	根治性为主	术后为主	新辅助为主
EBRT剂量	45-50.4 Gy	45-50.4 Gy	50-50.4 Gy
腔内放疗	宫颈加量(A点6-7Gy×4-5)	阴道残端(VBT) 无	
化疗方案	DDP周疗	±化疗	5-FU/卡培他滨
关键试验	GOG120	PORTEC系列	RAPIDO/PRODIGE-23

剂量对比记忆口诀

70打头颈 (NPC/扁桃体/下咽) **60**照脑食肺 (GBM/食管/肺癌) **50**管盆乳 (盆腔肿瘤/乳腺) **NK/T**淋巴瘤
站中间 (50-56) **CROSS** = 41.4 (唯一记这个数) **短程直肠** = 25/5 (5天搞定) **SCLC** = 45/30 BID
(唯一超分割)

★ 一句话速记 (每癌种一行)

癌种	速记
鼻咽癌	放疗核心不开刀，70/33 SIB，诱导+同步是局晚标配
扁桃体癌	口咽鳞癌HPV要查，70/33同鼻咽，术后ECE/切缘+加化疗
下咽癌	保喉第一诱导筛，70/33同头颈，预后最差
NK/T淋巴瘤	放疗极敏感50-56Gy，L-Asp是命根，CHOP无效
脑胶质瘤	GBM=Stupp60/30+TMZ，CTV外扩2cm沿白质，低级别50.4-54
食管癌	根治60/30，CROSS 41.4/23是新辅助，CTV上下扩3-5cm最大
肺癌	根治60-66，SBRT要BED ₁₀ ≥100，SCLC 45/30 BID，PACIFIC巩固
乳腺癌	保乳必放疗50/25+加量，根治术后胸壁+LN 50，大分割42.56/16
胰腺癌	手术率低放疗争议，术后45-50.4，SBRT 33-40/5f
宫颈癌	根治放疗=EBRT45-50.4+BT，EQD2≥85Gy，Sedlis/Peters分高中危
子宫内膜癌	术后为主45-50.4，中危选VBT(6Gy×3)，PORTEC系列
直肠癌	新辅助为主50/25-28f，短程25/5f，TNT是趋势

最后更新：2026-05-19